Der Zuhörer

campus naturalis HPB Block 7

F4 Teil 1, Angststörungen,
Belastungsreaktionen
HeilPrG, PsychThG

campus naturalis – Seminar HPB W07

Freitag/Montag

- Was ist Angst?
- Erarbeiten F4:
  - einfache Phobien
  - soziale Phobie
  - Agoraphobie

© Steffen Zöhl

campus naturalis – Seminar HPB W07

Samstag/Dienstag

- HeilPrG, PsychThG
- Gruppenarbeiten (Panikstörung, generalisierte Angststörung, Zwangsstörungen, akute Belastungs-reaktion, posttraumatische Belastungsstörung, Anpassungsstörungen)
- Praktische Fälle

campus naturalis – Seminar HPB W07

Sonntag/Mittwoch

- Wiederholung F4
- Prüfungssimulation Schwerpunkt F4 Auswertung
- Praktische Fälle

Angst

von indogermanisch *anghu „beengend“ über althoch-deutsch angust, verwandt mit lateinisch angustus bzw. angustia für „Enge, Beengung, Bedrängnis“ und angor „Würgen“

Was ist Angst ?

- Reaktion auf wahrgenommene, vorgestellte oder erwartete Gefahr/Bedrohung
- „Aktivierungsmodus“– Steigerung der Leistungsfähigkeit – Konzentration -Wachsamkeit – Energie – Aktivität
- Schutz
- Potentiale: über-sich-hinaus-wachsen
- Abwehr- und Fluchtreflexe
- Handlungsaktivität

Was ist Angst ?

- **wichtiger, positiver Effekt**
- elementarer, angeborener Affekt zur Herstellung eines (gesamt)körperlichen Spannungszustandes, der (ursprünglich) eine maximale Abwehr-/Fluchtbereitschaft ermöglicht
- evolutionär bedeutsam - die Ängstlichen (Wachsamen) haben besser überlebt
- macht aufmerksam, aktiviert die Reaktion, steigert die Leistungsfähigkeit und Handlungsmotivation

Begriffsbestimmungen

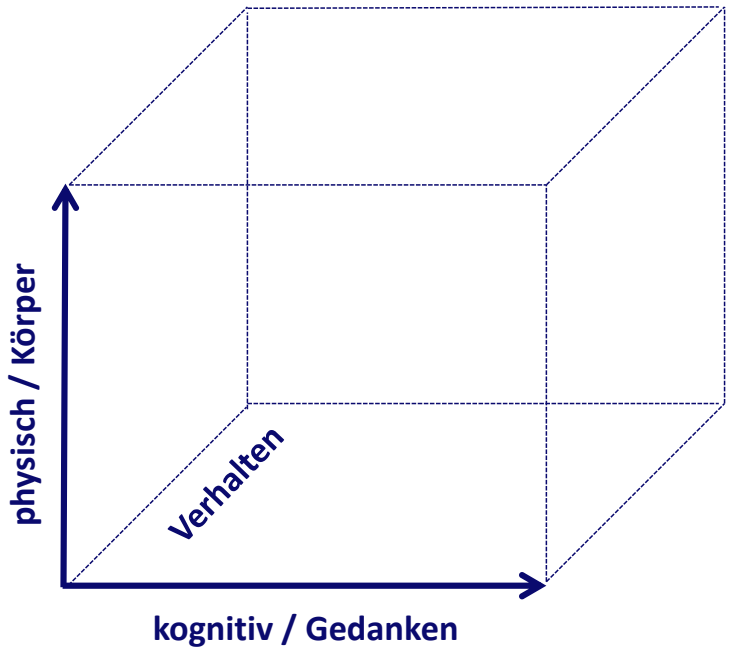
Konkret bestimmbare, Angst auslösende Faktoren (Dinge, Situationen)	**Extrem, anfallartig Erregungsintensität verhindert rationales Handeln**	**grundsätzlich, unange-messene Reaktion, Überbewertung der Faktoren**	**Symptom körperlicher Erkrankungen (z.B. Vitamin B-Mangel, Unterzuckerung, Hyper-thyreose, Stamm-hirnverletzungen, Nebennierenmarks-Tumor) oder Drogenmißbrauch**
Furcht	Panik	Ängstlichkeit / Angstneigung	Somatogen
real kaum/nicht bedrohlich ➔ Phobie		generalisierte Angststörung	

Wie äußert sich Angst ?

- körperliche Anspannung
- Herzklopfen/-rasen
- Schweißausbrüche
- Mundtrockenheit
- Zittern
- Bauchschmerzen
- Durchfall
- Spontane Blasenentleerung
- Pupillenerweiterung
- Gefäßverengung

- Auch diese physischen Reaktionen auf Angst können angstauslösend oder -verstärkend sein – hierbei kommt es tlws. zur „Angst vor der Angst“.

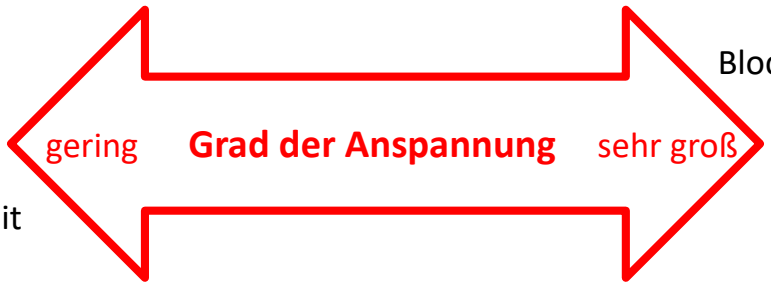
Dimensionen der Angst



Reaktionen

- Angst hat individuelle Parameter – welche Faktoren als Auslöser fungieren und das Ausmaß der empfundenen Gefahr und die emotionale Reaktion darauf, kann sehr individuell sein.

Steigerung der seelischen und körperlichen Leistungsfähigkeit



Blockade der geistigen Konzentration und Wahrnehmung + Lähmung der Bewegung

Reaktionsformen / Bewältigungsstrategien

Kampf	Flucht	Unterwerfung
Überkompensation, Aggression, Bekämpfen	Vermeiden, Entziehen, Fliehen, Weglaufen	Verdrängen, Hinnehmen, Erstarren, Aufgeben
Wut, Hass, Stolz, Ego, innerer Antrieb/Mut	Schutz, Sicherheit, Festhalten, friedlicher Weg	(Selbst)Zweifel, Hilflosigkeit, Minderwertigkeitsgefühl, Überforderung

Grundformen der Angst nach Fritz Riemann

Angst vor der Selbsthingabe	Angst vor der Selbstwerdung	Angst vor der Wandlung	Angst vor der Notwendigkeit
als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt	als Ungeborgenheit und Isolation erlebt	als Vergänglichkeit und Unsicherheit erlebt	als Endgültigkeit und Unfreiheit erlebt
Sehnsucht nach Individualität	Sehnsucht nach Nähe	Sehnsucht nach Beständigkeit	Sehnsucht nach Ver-änderung/Neuem
Schizoide Persönlichkeit	Depressive Persönlichkeit	zwanghafte Persönlichkeit	Hysterische Persönlichkeit

Charakteristika der 4 Angsttypen

Schizoide Persönlichkeit	Depressive Persönlichkeit	zwanghafte Persönlichkeit	Hysterische Persönlichkeit
Person unabhängig, autark, distanziert, sachlich	Person hingebend, ‚hilflos‘ abhängig, selbstlos	Person sicherungsorientiert planend, Kontrolle	Person Fernweh, Freiheit spontan, unüberlegt
Liebe bindungsscheu, lose (Sex)Partner	Liebe Harmonie, Verlust-angst, unterwürfig,	Liebe Kontrolle, Macht, Treue, Regeln, Geld	Liebe leidenschaftlich, (Selbst)Bestätigung
Aggression isolierte, triebhafte Abreaktion	Aggression Konfliktscheu, sublimierend	Aggression vorsichtig, Zweck heiligt die Mittel	Aggression Narzist, Schein/Sein Selbstwert, Rache
Erleben Außenseiter Schwarz-Weiss	Erleben aufopfernd, schuldig, „heilig“	Erleben Sammler, Pedant, Perfektionist	Erleben „Schauspieler“ Dramaqueen

Betrachtungsansätze

- Tiefenpsychologisch
  Welche kindliche Erfahrungen/Erlebnisse und/oder nicht (ausreichend) verarbeitete, unterdrückte sexuelle oder aggressive Fantasien sind dafür verantwortlich ?
- Schematherapie (kognitiv-verhaltenstherapeutisch)
  Welche „Verwundung“ hat ein dysfunktionales Muster aus Erinnerungen, Emotionen, Gedanken(mustern)/Glaubenssätzen und Körperempfindungen geschaffen, die die Angst (als Reaktion) bewirkt.
- Verhaltenstherapie
  Woher kommt die Angst? Wie ist sie entstanden? Konfrontation mit Angstreizen „in sensu“ und „in vivo“, ohne „Notfallpräparate“, Desensibilisierung oder Flooding, Änderung der Erwartungshaltung, Ziel: Erkenntnis, Angst selbständig überwinden zu können

Angstformen (ICD)

- frei flottierende Angst
- phobische Angst
- Panik

- multifaktorielle Ätiologie
- genetisch, Persönlichkeitsstruktur, erlernt, symbolisch (tiefenpsychologisch, Konfliktbewältigung)

Epidemiologie

	Σ	M	F
Irgendeine Angststörung (F40,F41)	15,3	9,3	21,3
Panikstörungmit/ohne Agoraphobie	2,0	1,2	2,8
Agoraphobie	4,0	2,3	5,6
Soziale Phobie	2,7	1,9	3,6
Generalisierte Angststörung	2,2	1,5	2,9
Spezifische Phobie	10,3	5,1	15,4

12-Monats-Prävalenz von Angststörungen (nach M-CIDI/DSM-IV TR) in der Bevölkerung, gewichtete Daten, Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland, Robert-Koch-Institut (DEGS1-MH; N=5318) (Jacobi et al., 2014)

Therapien

- **Verhaltenstherapie** (Aufgabe Vermeidungsverhalten)
- **Reizüberflutung** („flooding“): Konfrontation mit maximal angstauslösender Situation + Aushalten bis eine physiologische Gewöhnung eintritt (Lerneffekt Ausbleiben gefürchteter katastrophaler Folgen)
- **systematische Desensibilisierung**: stufenweise gesteigerte Reizexposition + Entspannungsverfahren
- **Kognitive Therapie**: Änderung Denk- und Bewertungsstile, Umstrukturierung angsterhaltender Gedanken

Therapien

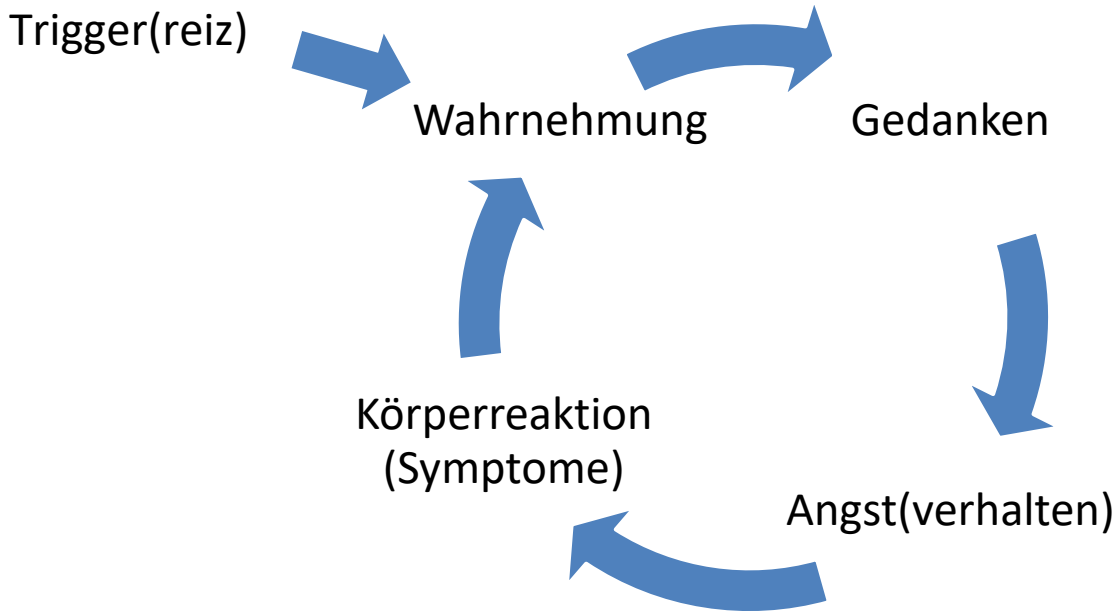
- **Psychoanalytische und tiefenpsychologische Psychotherapieverfahren**
- Aufdecken und „Durcharbeiten“ unbewusster Konflikte mit misslungenen Kompromisslösungen (Reaktivierung der ursprünglichen Affekte)

Therapien

- **Entspannungsverfahren**
- **Hypnose**therapie, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (PMR), Biofeedback

- **Medikamente**
- Anxiolytika, Antidepressiva, Benzodiazepine, Neuroleptika

Teufelskreis (Kreislauf) der Angst



Klassifikation

- F40 phobische Störungen
- F40.0 **Agoraphobie**
- .00 ohne Panikstörung / .01 **mit Panikstörung**
- F40.1 **soziale Phobien**
- F40.2 **spezifische (isolierte) Phobien**
- F41 andere Angststörungen
- F41.0 **Panikstörung** (episodisch paroxysmale Angst)
- .00 mittelgradig / .01 schwer
- F41.1 **generalisierte Angststörung**

Gruppenarbeit

- 3 Gruppen:
- **Agoraphobie**
- **soziale Phobie**
- **spezifische Phobien**

- Vorbereitungszeit: ca. 45min
- Vortrag: ca. 15min

Tag 2
Wiederholung

F4

F40.0 Agoraphobie

Agoraphobie

- urspr. Platzangst (griech. agora - Marktplatz) - Angst vor weiten Plätzen und Menschenmengen, heute weiter gefasst - alltägliche Situationen
- Lebenszeitprävalenz ca. 5%
- mehr Frauen als Männer

Agoraphobie

- Ängste, das Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, in **Menschenmengen** und auf **öffentlichen Plätzen** zu sein, **alleine** mit Bahn, Bus oder Flugzeug zu **reisen**
- Trigger - **fehlende „Fluchtmöglichkeit“**
- **häufig kombiniert mit Panikstörung**
- depressive und zwanghafte Symptome sowie soziale Phobien sind häufig zusätzlich vorhanden
- **Vermeidungsverhalten** steht oft im Vordergrund

F4

F40.1 soziale Phobien

Soziale Phobie

- auch Anthro(po)phobie, soziale Neurose, Sozialphobie
- Lebenszeitprävalenz ca. 4-11%
- mehr Frauen als Männer

Soziale Phobie

- deutliche **Furcht im Zentrum der Aufmerksamkeit** zu stehen oder sich **peinlich** oder erniedrigend **zu verhalten**
- **deutliche Vermeidung** im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen, in denen die Angst besteht, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten
- Ängste treten **in sozialen Situationen** auf, wie Essen oder Sprechen in der Öffentlichkeit, Begegnung von Bekannten in der Öffentlichkeit sowie Hinzukommen oder Teilnahme an **kleinen Gruppen**, z.B. bei Partys, Klassenräume
- Die Symptome können sich **bis zu Panikattacken** steigern.

Prüfungsangst (vgl. wikipedia)

- Angst vor der Bewertung der persönlichen (Leistung)sfähigkeit, die den Betroffenen daran hindern kann, sein Wissen und/oder Können bei einer Prüfung unter Beweis zu stellen.
- Grundsätzlich kann sie aber auch zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit führen.
- Sonderform der sozialen Phobie
- Besonders bei Personen mit Lernbehinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten

F4

F40.2 spezifische (isolierte) Phobien

spezifische (isolierte) Phobien

- auch einfache Phobien
- Lebenszeitprävalenz ca. 13%
- mehr Frauen als Männer

- Herzerkrankungen
- Krebs, Erkrankungen (Hypochondrie, Cyberchondrie)
- Vögel, Katzen, Hunde, Tiere
- Schmutz oder Ansteckung
- Toten und damit assoziierten Dingen
- Neuerungen
- Phobophobie (Angstsensitivität)
- Strahlung, Röntgenstrahlen
- Gesellschaft oder Menschen im Allgemeinen/in sozialen Situationen negativ bewertet zu werden
- Friedhöfen/lebendig begraben zu werden

Angst - Phobie - Panik

Erythrophobie	
Gelotophobie	
Gephyrophobie	
Haematophobie	
Herpetophobie	
Klaustrophobie	
Methatesiophobie	
Nomophobie	
Paraskavedekatriaphobie	
Siderodromophobie	
Trypanophobie / Vaccinophobie	

campus naturalis – Seminar HPB W07

Gruppenarbeit

- 6 Gruppen:
- **Panikstörung**
- **generalisierte Angststörung**
- **Zwangsstörungen**
- **akute Belastungsreaktion**
- **posttraumatische Belastungsstörung**
- **Anpassungsstörungen**

- Vorbereitungszeit: ca. 50min
- Vortrag: ca. 15min

Psychotherapeuten-gesetz (PsychThG)

Psychotherapeutengesetz - PsychThG

- Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psycho-therapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten - seit 1.1.1999 in Kraft
- schützt Bezeichnung „Psychotherapeut_in“ für
- **ärztliche/r Psychotherapeut_in**
  Medizinstudium + Therapieausbildung
- **Psychologische/r Psychotherapeut_in**
  Psychologiestudium + Therapieausbildung
- **Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut_in**
  Pädagogik, Sozialpädagogik + Therapieausbildung

Heilberufe in der Psychotherapie

Heilberufe in der Psychotherapie

- Psychiater (Facharzt für Psychiatrie)
- Neurologe (Facharzt für Neurologie)
- Psychotherapeut
  - ärztlicher Psychotherapeut (Ärzte nach einer mehrjährigen psychotherapeutischen
  - Fortbildung in einem anerkannten Verfahren)
  - Psychologischer Psychotherapeut
  - Kinder- und Jugendpsychotherapeut
- Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie

Heilberufe in der Psychotherapie

- (nicht) akademische Berufe

	Qualifikation	Psychotherapie	Heil-erlaubnis	Medikamente verordnen
Psychiater	Medizinstudium, FA für Psychiatrie	bei Therapieaus-bildung	☑	☑
Psychologe	Psychologiestudium	ø	ø	ø
Neurologe	Medizinstudium, FA für Neurologie	bei Therapieaus-bildung	☑	☑
Psychotherapeut	Psychologiestudium + Therapieausbildung	☑	☑	ø
Heilpraktiker (für Psychotherapie)	Überprüfung durch Gesundheitsamt	Therapieaus-bildung	☑	ø

begriffliche Abgrenzungen

- **Psychiatrie** - Vorbeugung, Diagnostik und Behandlung von psychischen Störungen
- **Neurologie** - Nervensystem, seine Erkrankungen und deren med. Behandlung (ZNS, PNS, [Para]Sympaticus)
- **Psychologie** - Wissenschaft zur Beschreibung/Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens, der Entwicklung sowie aller dafür maßgeblichen Faktoren

Psychotherapie

- altgriechisch ψυχή psyché ‚Atem, Hauch, Seele'
- Ort menschlichen Fühlens und Denkens, sowie die Summe aller geistigen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen. Im Gegensatz zur Seele umfasst die Psyche keine transzendenten Elemente.
- altgriechisch θεραπεύειν therapeúein ‚pflegen, sorgen' sowie altgriechisch θεραπεία therapeia „Heilung".

(wikipedia)

Psychotherapie

- Klaus Grawe: 5 grundlegende Wirkfaktoren der Psychotherapie (über die Therapieschulen hinweg)

- **Therapeutische Beziehung**
- Ressourcenaktivierung
- Problemaktualisierung
- Motivationale Klärung
- Problembewältigung

Psychotherapie

- **Therapeutische Beziehung**: Qualität der Beziehung zwischen Psychotherapeut/in und Patient/in
- **Ressourcenaktivierung**: positive Ressource - Motivation, Fähigkeiten und Interessen von PatientINNen.
- **Problemaktualisierung**: durch reale Situationen, intensives Erzählen, Imaginationen, Rollenspiele
- **Motivationale Klärung**: Bewusstsein (Ursprünge, Hintergründe, aufrechterhaltende Faktoren) zu Problem
- **Problembewältigung**: mittels bewährter Therapiemaß-nahmen - positive Bewältigungserfahrungen

begriffliche Abgrenzungen

- **Psychotherapie** - Behandlung von psychischen Erkrankun-gen mit psychologischen Mitteln
- **Psychoedukation** - Beratung/Aufklärung durch wissenschaftlich fundiertes Wissen über psychische Krankheiten (Krankheitsverständnis und -bewältigung, Therapie, Psychohygiene; z.B. PatientINNen und Umfeld)
- **Psychosomatik** - psychische Einflüsse auf körperliche Vorgänge/Erkrankungen F54

Psychologische Beratung

- Begriff nicht geschützt
- Hilfestellungen für psychisch gesunde Menschen mit konkreten Lebensproblemen
- z.B.: Coaching, Psycho-edukation, wirtschafts-psychologische Methoden, Kommunikationstrainings

Psychotherapie

- PsychThG, HeilPrG
- Tätigkeiten zur **Feststellung, Heilung oder Linderung** von Störungen mit Krankheitswert

Heilpraktikergesetz HeilPrG

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom 17. Februar 1939 (HeilPrG)

- angepasst durch Drittes Pflegestärkungsgesetz - PSG III im Dezember 2016

- Wer darf als HPP arbeiten?
- Was bedeutet „heilen“?
- Was darf ein HPP bzw. nicht?
- Wer bekommt / Wie bekommt man die Erlaubnis?
- Wie darf man sich / eine Praxis nennen?

Wer darf als HPP arbeiten?

- § 1 HeilPrG
- (1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, ausüben will, bedarf dazu der ***Erlaubnis***.
- (2) Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist ***jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit**** zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird.

*Wiederholungsabsicht, unabhängig von Bezahlung/Vergütung

Wer ... darf als HPP arbeiten?

- Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) 18.02.1939, zuletzt geändert am 23. Dezember 2016
- mindestens 25. Lebensjahr vollendet hat
- mindestens abgeschlossene Volksschulbildung
- die sittliche Zuverlässigkeit besitzt = keine strafrechtlichen oder sittlichen Verfehlungen *(polizeiliches Führungszeugnis)*
- in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs geeignet

Wer darf als HPP arbeiten?

- wenn sich aus einer Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Antragstellers durch das Gesundheits-amt, die auf der Grundlage von Leitlinien zur Überprüfung von Heilprak-tikeanwärtern durchgeführt wurde, ergibt, dass die Ausübung der Heilkunde durch den Betreffenden ***keine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung oder für die ihn aufsuchenden Patientinnen und Patienten*** bedeuten würde.
- Das Bundesministerium für Gesundheit macht Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärtern bis spätestens zum 31. Dezember 2017 im Bundesanzeiger bekannt. Bei der Erarbeitung der Leitlinien sind die Länder zu beteiligen.

Was bedeutet „heilen“?

- § 1 HeilPrG (2) Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur ***Feststellung, Heilung oder Linderung von <u>Krankheiten, Leiden oder Körperschäden</u> bei Menschen***, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird.
- Feststellung = Diagnose - wesentlicher Unterschied zu Gesundheitsfachberufen (z.B. Physiotherapeut)

Was darf ein HPP *(bzw. nicht)* ?

- „Heilen“ in der Praxis und bei Hausbesuchen
- Psychotherapie

NICHT:

- im Umherziehen arbeiten (ladungsfähige Adresse)
- **Medikamente verschreiben oder empfehlen**
- Atteste, Totenscheine, Krankenscheine austellen
- Zahnheilkunde, Geburtshilfe
- körperorientierte Arbeit

- nur mit Methoden arbeiten, die ausreichend erlernt sind

Wer bekommt / Wie bekommt man die Erlaubnis?

- § 1 (3) Wer die Heilkunde bisher berufsmäßig ausgeübt hat und weiterhin ausüben will, erhält die Erlaubnis nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen; er führt die Berufsbezeichnung "Heilpraktiker".
- § 2 (1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, bisher berufsmäßig nicht ausgeübt hat, kann eine Erlaub-nis nach § 1 in Zukunft nach Maßgabe der gemäß § 7 erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erhalten, die insbeson-dere Vorgaben hinsichtlich Kenntnissen und Fähigkeiten als Bestandteil der Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis enthalten sollen.

Berufsordnung für Heilpraktiker (auszugsweise)

- Schweigepflicht
- Aufklärungs-, Dokumentations- und Sorgfaltspflicht
- Weiterbildungspflicht
- Praxisräume
- Werbung / Praxisschilder
- Krankenbesuche
- Heilpraktiker und Arzneimittel
- Haftpflicht
- Meldepflicht
- Standesdisziplin

Tag 3
Wiederholung

F4
F41.0 Panikstörung

Panik(störung)

- auch **episodisch paroxysmale Angst**
- Panikattacke, Panikzustand
- Lebenszeitprävalenz ca. 3-4%
- einzelne Panikattacke: 7% Männer, 11% Frauen
- Panikstörung mit Agoraphobie 2x Frauen > Männer
- Panikstörung ohne Agoraphobie etwa ausgeglichen

- (ICD 10) Ausschluss: Panikstörung mit Agoraphobie (F40.0)

Panikstörung

- **wiederkehrende schwere Angstattacken** (Panik), die sich **nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken** und deshalb auch nicht vorhersehbar
- Intensität während ca. 10min (-30min) ansteigend
- sekundär die **Furcht zu Sterben**, vor **Kontrollverlust** oder die **Angst, wahnsinnig zu werden**
- keine Hauptdiagnose bei Depression (sekundäre Folge)
- **Angst vor der Angst** (Phobophobie)
- **Psychoedukation**

Panikstörung

- Die individuelle Variationsbreite bzgl. Inhalt und Schwere ist so groß, dass zwei Schweregrade - mittelgradig und schwer - mit der fünften Stelle differenziert werden können:
- F41.00 **mittelgradig**e Panikstörung: **mindestens vier Panikattacken in vier Wochen**
- F41.01 **schwer**e Panikstörung: **mindestens vier Panik-attacken pro Woche über einen Zeitraum von vier Wochen**

F4

F41.1 generalisierte Angststörung

generalisierte Angststörung

- auch Angstneurose, Angstreaktion
- Lebenszeitprävalenz ca. 7-8%
- mehr Frauen als Männer

generalisierte Angststörung

- **generalisierte und anhaltende Angst,** nicht auf bestimmte Umgebungsbedingungen beschränkt, oder auch nur besonders betont = „**frei flottierend**“
- Häufig wird die Befürchtung oder Sorge geäußert, der Betreffende selbst oder ein Angehöriger könnten demnächst erkranken oder einen Unfall haben
- **mindestens sechs Monate**, mit vorherrschender **Anspannung, Besorgnis und Befürchtungen** in Bezug auf alltägliche Ereignisse

F4

F42 Zwangsstörung

Zwangsstörung

- Lebenszeitprävalenz Zwangsstörung ca. 2%
- einzelne Zwangssymptome ca. 8% der Bevölkerung
- Frauen = Männer
- Beginn meist nach der Pubertät
- ¾ unbehandelter Fälle - chronisch

- anale Phase (übertriebene Sauberkeitserziehung, Ordnung, strenge Erziehung),
- tieferliegende Angst

Zwangsstörung

- wiederkehrende **Zwangsgedanken und -handlungen**

- **Zwangsgedanken** sind Ideen, Vorstellungen oder Impulse, die den Betroffenen immer wieder stereotyp beschäftigen, fast immer quälend
- die betroffene Person **versucht häufig erfolglos, Widerstand** zu leisten
- Die Gedanken werden als zur eigenen Person gehörig erlebt, selbst wenn sie als unfreiwillig und häufig abstoßend empfunden werden.

Zwangsstörung

- **Zwangshandlungen** oder -rituale sind Stereotypien, die ständig wiederholt werden. Sie werden weder als angenehm empfunden, noch dienen sie dazu, an sich nützliche Aufgaben zu erfüllen.
- oft als **Vorbeugung gegen** ein objektiv unwahrscheinliches Ereignis, das **Schaden** bringen oder bei dem Betroffene **selbst Unheil anrichten** könnten
- Verhalten im allgemeinen als sinnlos und ineffektiv erlebt -> Versuch, dagegen anzugehen
- meist **ständig Angst** -werden Zwangshandlungen unterdrückt, verstärkt sich die Angst deutlich

Zwangsstörung

- Zwangsimpulse - ein sich gegen den Willen der Betroffenen aufdrängendes Verlangen, bestimmte Handlungen auszuführen
- obwohl es regelmäßig nicht passiert - Impulse mit der Angst verbunden, dass die Handlungen real tatsächlich ausgeführt werden

Zwangsstörung Diagnostische Kriterien

- Zwangsgedanken und/oder Zwangshandlungen an den meisten Tagen - **mindestens zwei Wochen** lang
- **Betroffene leiden** unter den Zwangsgedanken und Zwangshandlungen oder werden in ihrer sozialen oder individuellen Leistungsfähigkeit behindert, meist durch den besonderen Zeitaufwand.

- **Ausschlussvorbehalt**: Die Störung ist nicht bedingt durch eine andere psychische Störung, wie **Schizophrenie** und verwandte Störungen (F2) oder **affektive Störungen** (F3).

Zwangsstörung Diagnostische Kriterien

- Merkmale Zwangsgedanken und Zwangshandlungen:
- 1. sie werden als **eigene Gedanken/Handlungen** von den Betroffenen angesehen und nicht von Außen (F2)
- 2. wiederholen sich dauernd und werden als unangenehm empfunden, und mindestens ein/e Zwangsgedanke/-handlung werden **als übertrieben und unsinnig anerkannt**

Zwangsstörung Diagnostische Kriterien

- Merkmale Zwangsgedanken und Zwangshandlungen:
- 3. die Betroffenen **versuchen, Widerstand zu leisten** (bei lange bestehenden Zwangsgedanken und -handlungen kann der Widerstand allerdings sehr gering sein). **Gegen mindestens eine/n Zwangsgedanken/-handlung wird gegenwärtig erfolglos Widerstand geleistet**
- 4. die **Ausführung** eines Zwangsgedankens oder einer Zwangshandlung ist für sich genommen **nicht angenehm** (dies sollte von einer vorübergehenden Erleichterung von Spannung oder Angst unterschieden werden)

Zwangsgedanken (Beispiele häufiger Themen)

- **Schmutz oder Verseuchung** (menschliche oder tierische Exkremente, Schmutz, Staub, Samen, Menstruationsblut, Keime, Infektionen)
- **Gewalt und Aggression** (körperlicher oder verbaler Angriff auf sich selbst oder andere Personen; Katastrophen, Tod, Krieg, Missgeschick, Unfälle)
- **Ordnung** (Ordentlichkeit, Symmetrie)
- **Religion** (Existenz Gottes, religiöse Praktiken und Rituale, Glaubenssätze, moralische Einstellungen) oder Magie
- **Sexualität** (sexuelle Handlungen an sich oder anderen, inzestuöse Impulse, sexuelle Leistungsfähigkeit)

Zwangshandlungen

- **Reinlichkeits-/Waschzwang** (Putzen, Hände waschen)
- **Kontrollzwang** (ständiges Überprüfung: Strom, Türen, Gas)
- **Ordnungszwang** (Symmetrie, perfekte Ordnung, Regeln)
- **Berührzwang** (bestimmte Dinge (nicht) anzufassen)
- **verbale Zwänge** (wiederholen von Ausdrücken, Sätzen oder Melodien)

Therapien

- **Verhaltenstherapie** (VT), Kognitive Therapie (KT) und Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)
- Konfrontation mit Reaktionsverhinderung bzw. „Reaktionsmanagement“ (Modelllernen von Therapeut + inhaltliche Auseinandersetzung mit Befürchtungen) emotional processing
- bei 60 bis 90 % der Zwangspatienten - Besserung

- Habituationstraining, Psychoanalyse
- medikamentös - AD, Neuroleptika

Zwangsstörung vs. zwanghafte Persönlichkeitsstörung

- (versuchter) Widerstand vs. Persönlichkeitsaspekt
- ich-dyston vs. ich-synton
- Leidensdruck (innerlich) vs. Leidensdruck (ggü. Umwelt)
- Verheimlichen vs. Ausleben

Therapie

- Lebenszeitprävalenz ca. 5%
- mehr Frauen als Männer

- Verhaltenstherapie, Psychoedukation
- Flooding, Reizüberflutung, Expositionstherapie
- systematische Desensibilisierung (in sensu, in vivo)
- kognitive Umstrukturierung (angsterhaltende Gedanken)

- Anxiolytika, Trizyklische Antidepressiva und Selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer

F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen

- Besonderheit: Angabe von ein oder zwei ursächlichen Faktoren: ein **außergewöhnlich belastendes Lebens-ereignis**, das eine akute Belastungsreaktion hervorruft, oder eine **besondere Veränderung im Leben**, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation geführt hat und eine Anpassungsstörung hervorruft.

F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen

- auch weniger schwere psychosoziale Belastungen (life events) den Beginn und das Erscheinungsbild auch zahlreiche anderer Störungen dieses Kapitels auslösen und beeinflussen können, ist ihre ätiologische Bedeutung doch nicht immer ganz klar -> **individuelle Vulnerabilität**
- unter F43 aufgeführte Störungen - immer als direkte Folge der akuten schweren Belastung oder des kontinuierlichen Traumas

F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen

- Belastendes Ereignis oder die andauernden, unangenehmen Umstände sind primäre und ausschlaggebende Kausalfaktoren und die Störung wäre ohne ihre Einwirkung nicht entstanden
- behindern erfolgreiche Bewältigungsstrategien und führen zu Störung der sozialen Funktionsfähigkeit

F43.0 akute Belastungsreaktion

- vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung entwickelt, und die im Allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt.
- Die individuelle Vulnerabilität und die zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen (coping-Strategien) spielen bei Auftreten und Schweregrad der akuten Belastungsreaktionen eine Rolle.

F43.0 akute Belastungsreaktion

- Die Symptomatik zeigt typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild, beginnend mit einer Art von „Betäubung“ mit einer gewissen Bewusstseinseinengung und eingeschränkten Aufmerksamkeit, einer Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten und Desorientiertheit.
- Danach ggf. Rückzug aus der Umweltsituation (bis hin zu dissoziativem Stupor) oder aber ein Unruhezustand und Überaktivität (wie Fluchtreaktion oder Fugue).

F43.0 akute Belastungsreaktion

- Vegetative Zeichen panischer Angst wie Tachykardie, Schwitzen und Erröten treten zumeist auf.
- Die Symptome erscheinen im Allgemeinen innerhalb von Minuten nach dem belastenden Ereignis und gehen innerhalb von zwei oder drei Tagen, oft bereits innerhalb von Stunden zurück.
- Teilweise oder vollständige Amnesie bezüglich dieser Episode kann vorkommen. (Bei andauernden Symptome - Änderung der Diagnose in Erwägung ziehen

F43.0 akute Belastungsreaktion

- Dazugehörige Begriffe: akute Krisenreaktion, akute Belastungsreaktion, Kriegsneurose (combat fatigue), Krisenzustand, psychischer Schock

- Diagnostische Kriterien
- A. Erleben einer außergewöhnlichen psychischen oder physischen Belastung.
- B. Der außergewöhnlichen Belastung folgt unmittelbar der Beginn der Symptome (innerhalb einer Stunde).

F43.0 akute Belastungsreaktion

- C. Es gibt zwei Symptomgruppen. Die akute Belastungsreaktion wird unterteilt in:
- F43.00 leicht - nur Symptome aus Gruppe 1.
- F43.01 mittelgradig - Symptome aus Gruppe 1. und
- zwei Symptome aus Gruppe 2.
- F43.02 schwer - Symptome aus Gruppe 1. und vier Symptome der Gruppe 2. oder dissoziativer Stupor

F43.0 akute Belastungsreaktion

- 1. Die Kriterien B., C. und D. der generalisierten Angststörung (F41.1)
- 2. a. Rückzug von erwarteten sozialen Interaktionen, b. Einengung der Aufmerksamkeit
- c. offensichtliche Desorientierung
- d. Ärger oder verbale Aggression
- e. Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit
- f. unangemessene oder sinnlose Überaktivität
- g. unkontrollierbare und außergewöhnliche Trauer (zu beurteilen nach den jeweiligen kulturellen Normen)

F43.0 akute Belastungsreaktion

- D. Wenn die Belastung vorübergehend ist oder gemildert werden kann, beginnen die Symptome nach spätestens acht Stunden abzuklingen. Hält die Belastung an, beginnen die Symptome nach spätestens 48 Stunden nachzulassen.
- E. Ausschlussvorbehalt: Derzeitig liegt keine andere psychische oder Verhaltensstörung der ICD-10 vor (außer F41.1 generalisierte Angststörung und F60 Persönlichkeitsstörungen). Das Ende einer Krankheitsepisode einer anderen psychischen oder Verhaltensstörung muss mehr als drei Monate zurückliegen.

F43.1 posttraumatische Belastungsstörung

- verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.
- Prädisponierende Faktoren wie bestimmte Persönlichkeitszüge oder neurotische Erkrankungen in der Vorgeschichte können die Schwelle für die Entwicklung dieses Syndroms senken und seinen Verlauf erschweren, sind aber weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten der Störung zu erklären.

F43.1 posttraumatische Belastungsstörung

- Typische Merkmale sind **das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhall-erinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Alpträumen**, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten.
- Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten.

F43.1 posttraumatische Belastungsstörung

- Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen verbun-den, und Suizidgedanken sind nicht selten.
- Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechsel-haft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden.

F43.1 posttraumatische Belastungsstörung

- Bei wenigen Betroffenen nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und geht dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung über.

- Diagnostische Kriterien
- A. Die betroffene Person war einem kurz- oder langhaltenden Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das bei nahezu jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde.

F43.1 posttraumatische Belastungsstörung

- B. Anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhallerinnerungen, lebendige Erinnerungen, sich wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen.
- C. Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr im Zusammenhang stehen, werden tatsächlich oder möglichst vermieden. Dieses Verhalten bestand nicht vor dem belastenden Erlebnis.

F43.1 posttraumatische Belastungsstörung

- D. Entweder 1. oder 2.
- 1. Teilweise oder vollständige Unfähigkeit, einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern.
- 2. Anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung (nicht vorhanden vor der Belastung) mit zwei oder mehr der folgenden Merkmale:
- a. Ein- und Durchschlafstörungen
- b. Reizbarkeit oder Wutausbrüche
- c. Konzentrationsschwierigkeiten
- d. Hypervigilanz
- e. erhöhte Schreckhaftigkeit

F43.1 posttraumatische Belastungsstörung

- E. Die Kriterien B., C. und D. treten **innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis** oder nach Ende einer Belastungsperiode auf. (Aus bestimmten Gründen, z. B. wissenschaftliche Untersuchungen, kann ein späterer Beginn berücksichtigt werden, dies sollte aber gesondert angegeben werden.)

F43.2 Anpassungsstörungen

- Zustände von subjektiver Bedrängnis und emotionaler Beeinträchtigung, die im Allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten.
- Die Belastung kann das soziale Netz des Betroffenen beschädigt haben (z.B. Trauerfall oder Trennung) oder das weitere Umfeld sozialer Unterstützung oder sozialer Werte (z.B. Flucht).

F43.2 Anpassungsstörungen

- Sie kann auch in einem größeren Entwicklungsschritt oder einer Krise bestehen (wie Schulbesuch, Elternschaft, Misserfolg, Erreichen eines ersehnten Zieles und Ruhestand).
- Die individuelle Prädisposition oder Vulnerabilität spielt bei dem möglichen Auftreten und bei der Form der Anpassungsstörung eine bedeutsame Rolle; es ist aber dennoch davon auszugehen, dass das Krankheitsbild ohne die Belastung nicht entstanden wäre.

F43.2 Anpassungsstörungen

- Die Anzeichen sind unterschiedlich und umfassen depressive Stimmung, Angst, Sorge (oder eine Mischung von diesen). Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den alltäglichen Gegebenheiten nicht zurechtzukommen, diese nicht vorausplanen oder fortsetzen zu können.
- Störungen des Sozialverhaltens können insbesondere bei Jugendlichen ein zusätzliches Symptom sein.
- Hervorstechendes Merkmal kann eine kurze oder längere depressive Reaktion oder eine Störung anderer Gefühle und des Sozialverhaltens sein.

F43.2 Anpassungsstörungen

- Dazugehörige Begriffe: Kulturschock, Trauerreaktion, Hospitalismus bei Kindern
- Bei Kindern sind regressive Phänomene wie erneutes Einnässen, Babysprache oder Daumenlutschen häufig Teil dieses Syndroms. Wenn diese Symptome im Vordergrund stehen, sollte F43.23 benutzt werden.

F43.2 Anpassungsstörungen

- **Trauerreaktionen** jeglicher Dauer, die wegen ihrer Form oder wegen ihres Inhalts als abnorm betrachtet werden, sollten eine der unten aufgeführten Kodenummern erhalten (F43.22-F43.25), und diejenigen von angemessener Form und Inhalt, aber einer **Dauer, die sechs Monate überschreitet**, sollten unter F43.21 (längere depressive Reaktion) kodiert werden.

F43.2 Anpassungsstörungen

- Diagnostische Kriterien
- A. Identifizierbare psychosoziale Belastung, von einem nicht außergewöhnlichen oder katastrophalen Ausmaß; Beginn der Symptome innerhalb eines Monats.
- B. Symptome und Verhaltensstörungen (außer Wahngedanken und Halluzinationen) wie sie bei affektiven Störungen, bei Störungen des Kapitels F4 und bei den Störungen des Sozialverhaltens (F91) vorkommen. Die Kriterien einer einzelnen Störung werden aber nicht erfüllt. Die Symptome können in Art und Schwere variieren.

F43.2 Anpassungsstörungen

- Das vorherrschende Erscheinungsbild der Symptome sollte mit der fünften Stelle weiter differenziert werden:
- F43.20 kurze depressive Reaktion
  Ein vorübergehender leichter depressiver Zustand, der nicht länger als einen Monat andauert.
- F43.21 längere depressive Reaktion
  Ein leichter depressiver Zustand als Reaktion auf eine länger anhaltende Belastungssituation, der zwei Jahre aber nicht überschreitet.

F43.2 Anpassungsstörungen

- F43.22 Angst und depressive Reaktion gemischt
  Sowohl Angst als auch depressive Symptome sind vorhanden, jedoch nicht in größerem Ausmaß als bei Angst und depressiver Störung, gemischt (F41.2) oder anderen gemischten Angststörungen (F41.3).

F43.2 Anpassungsstörungen

- F43.23 mit vorwiegender Störung von anderen Gefühlen
  Die Symptome betreffen zumeist verschiedene affektive Qualitäten, wie etwa Angst, Depression, Besorgnis, Anspannung und Ärger. Die Symptome für Angst und Depression können die Kriterien für Angst und depressive Störung gemischt oder andere gemischte Angststörungen erfüllen, sind aber nicht so dominierend, dass andere spezifischere depressive oder Angststörungen diagnostiziert werden können. Auch für Reaktionen im Kindesalter, bei denen regressives Verhalten wie Bettnässen oder Daumenlutschen zusätzlich vorliegen.

F43.2 Anpassungsstörungen

- F43.24 mit vorwiegender Störung des Sozialverhaltens
  Die hauptsächliche Störung betrifft das Sozialverhalten, z.B. kann sich eine Trauerreaktion in der Adoleszenz in aggressivem oder dissozialem Verhalten äußern.
- F43.25 mit gemischter Störung von Gefühlen und Sozialverhalten
  Sowohl emotionale Symptome als auch Störungen des Sozialverhaltens sind bestimmende Symptome.
- F43.28 mit sonstigen näher bezeichneten vorherrschenden Symptomen
- F43.29 nicht näher bezeichnete Anpassungsstörung

F43.2 Anpassungsstörungen

- C. Die Symptome dauern **nicht länger als sechs Monate nach Ende der Belastung** oder ihrer Folgen an, außer bei der längeren depressiven Reaktion (F43.21). Bis zu einer Dauer von sechs Monaten kann die Diagnose einer Anpassungsstörung gestellt werden. Unabhängig von der Erfüllung dieses Zeitkriteriums kann stets eine vorläufige Diagnose gestellt werden.

- F43.8 sonstige Reaktionen auf schwere Belastung
- F43.9 Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet

Psychohygiene

- Wer ist der wichtigste Mensch in Deinem Leben?

- Balance/Ausgleich schaffen
- Mentale Gesundheit
- Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erhalten
- Lebensqualität, Zufriedenheit, Selbstwertgefühl, Gelassenheit, Belastbarkeit
- Burn out-Prophylaxe

Psychohygiene

- soziale Kontakte (Familie, Freunde)
- Sport und Bewegung
- Ausgewogene Ernährung
- Ausreichend Schlaf und Ruhepausen
- Entspannungsmethoden
- Hobbys, Reisen, Abenteuer
- Achtsamkeit, MBSR, Resilienztraining,
- Distanzierungs-, Entlastungs- und Copingstrategien
- Ressourcenaktivierung, -findung
- Intervision, Supervision

Zur Person

Ich bin Steffen Zöhl, geb. 1975 und liebe es, Menschen zu motivieren und von sich selbst zu begeistern. Das Vertrauen zwischen meinen Klienten und mir ist in meinen Augen der entscheidendste Erfolgsfaktor für eine Therapie. Mit meinen Klienten arbeite ich gerne an ihren Stärken, um Ängste, Blockaden und tieferliegende Themen aufzulösen. Humor, Tiefgründigkeit und Empathie helfen mir insbesondere bei Themen wie Ängsten / Phobien, Stress, Selbstwertgefühlen und diversen Beziehungsthemen (Paare, Selbstwert, Trauer, Teams [Konflikte, Motivation, Kommunikation]).

Das Vertrauen zwischen meinen Klienten und mir ist in meinen Augen der entscheidendste Erfolgsfaktor für ein gutes Gespräch oder eine Therapie. Seit meiner Kindheit vertrauen mir immer wieder -teilweise noch fremde- Menschen, Freunde oder Bekannte sehr persönliche Dinge an und schenken mir ihr Vertrauen. Dieses Geschenk nutze ich gerne, um damit Menschen zu begleiten, ihren eigenen Weg und ihr Glück (wieder) zu finden.

Folgende Ausbildungen bringe ich –neben dem, was das Leben mir geschenkt hat- in meine Arbeit ein:

- Heilpraktiker für Psychotherapie (HPP)
- Integrative Psychotherapie (Institut Christoph Mahr)
  Basiskurs, Grundausbildung, Companion
- EMDR-Therapeut (VDH/DGMT)
- Hypnose Practitioner (Institut Christoph Mahr)
- Hypnose-Master (Harald Krutiak, Floris Weber
- Hypnoanalyse (Floris Weber)
- Mediation (div. Ausbildungen)
- Kinderpsychologie (Laudius Akademie)
- Trauerbegleitung (Laudius Akademie)

Quellen / Literaturhinweise:

Riemann, Fritz: Grundformen der Angst 41., Auflage, Verlag Reinhardt 2013, ISBN-10: 3497024228

Witzleben, Ines von / Schwarz, Aljoscha A.: Endlich frei von Angst. Denkmuster erkennen und unbeschwert leben. Mit praxiserprobten 7-Schritte- Übungs-Programm, Weltbild 2010, ISBN: 9783828941939 oder 978-3774266360

Poehlke, Thomas: Gk3 Psychiatrie, Georg Thieme Verlag

Dilling,H./Freyberger, H.J.: Taschenführer zur ICD 10-Klassifikation psychischer Störungen, Verlag Hans Huber (2012)

https://de.wikipedia.org/wiki/Angst

https://de.wikipedia.org/wiki/Systematische_Desensibilisierung

https://de.wikipedia.org/wiki/Flooding_(Psychotherapie)

https://de.wikipedia.org/wiki/Progressive_Muskelentspannung

© Steffen Zöhl